11 Uno, nessuno e centomila. Identità, ruolo e trasformazioni del Distretto Socio-Sanitario

di Federica Dalponte, Lucia Ferrara, Valeria D. Tozzi, Angelica Zazzera[1,2,3]

11.1 La rinnovata centralità del Distretto Socio-Sanitario

Il presente contributo rilancia la riflessione sul Distretto Socio-Sanitario (DSS) in ragione della rilevanza ad esso riconosciuta dal DM77/22 e riprende alcuni elementi emersi nel Rapporto OASI 2022 (Dalponte *et al.*, 2022). Il concetto di DSS fa riferimento a una pluralità di significati tra di loro interconnessi: i) una struttura organizzativa dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) nata con fini di integrazione su base territoriale di una filiera di servizi ampia e frammentata; ii) un territorio inteso come partizione dell'azienda con un bacino di popolazione caratterizzato da dinamiche economiche, sociali e sanitarie specifiche, che nel tempo è andato ampliandosi per territorio e popolazione; iii) il «luogo» delle relazioni fra i soggetti istituzionali che contribuiscono al sistema delle attese e compartecipano alla salute della comunità (dagli enti locali, al terzo settore, fino alle imprese locali). Queste diverse accezioni vengono interrogate dal ridisegno dei servizi indotto dal DM77/22 almeno per le seguenti ragioni: la realizzazione di nuove o rinnovate strutture di offerta (si pensi alle Case della Comunità) e l'attivazione di processi e strumenti di integrazione di scala distrettuale

[1] Il capitolo è frutto di un lavoro comune delle autrici, in particolare i §§ 11.1 e 11.3.1 sono da attribuire a Federica Dalponte, il §§ 11.2 e 11.3.2 ad Angelica Zazzera, i §§ 11.2.1 e 11.3.3 a Lucia Ferrara e il § 11.4 a Valeria D. Tozzi.

[2] La presente ricerca si inserisce nel Network DiSS, con il contributo non condizionante di Viatris. Si ringraziano tutti i direttori e le direttrici di DSS che hanno partecipato al Network DiSS e contribuito al capitolo: Atzori Aldo, Baccarini Michele, Caldesi Roberta, Camplone Ilaria, Ceccarelli Paola, Chini Claudio, Dalla Torre Lucia, De Gennaro Girolama, Di Bernardo Claudia, Furnari Giacomo, Maricchio Rita, Palmonari Caterina, Pennazio Roberta, Petruio Alessandra, Poliandri Giuseppina, Rossi Gianrocco, Sandroni Marzia, Sasso Claudio, Serra Maria Cristina, Sforzin Simona, Sibilano Angelamaria, Simoncini Mara, Spinazzola Domenico, Tamagnini Mirco, Vota Ornella.

[3] Per lo svolgimento di alcune analisi nel presente capitolo le ricercatrici hanno utilizzato il software di AI ChatGPT Education.

(ad esempio, le diverse centrali quali il numero 116117 o le Centrali Operative Territoriali – COT), che mettono in discussone il sistema delle responsabilità e le prassi operative. Inoltre, sempre il medesimo Decreto evidenzia la necessità di adattare alle caratteristiche delle singole popolazioni il modello di offerta dei servizi e di valorizzare la prossimità delle cure a garanzia dell'equità di accesso. Tali spinte stanno trasformando l'offerta di cure già presente, orientando i modelli di servizio per target di popolazione presente in ciascun DSS, non rinunciando all'omogeneità delle prassi e delle procedure operative.

Nelle edizioni 2023 e 2024 del Rapporto OASI (Cinelli *et al.*, 2023; Cinelli *et al.*, 2024) veniva evidenziata la «magnitudo» del Decreto in ragione degli investimenti legati alla Missione 6 del PNRR: tutte le ASL erano (e sono) impegnate nella sua implementazione e nel rispetto degli impegni assunti col PNRR. Le scadenze legate alle *tranche* di finanziamento del Piano rappresentano un incentivo e una motivazione importante anche all'attuazione dei contenuti del DM77/22. Inoltre, se i primi anni del PNRR hanno visto un maggiore protagonismo regionale nel progettare numerosità, tipologia e distribuzione delle strutture da costruire o rinnovare, gli ultimi anni stanno vedendo le aziende sanitarie protagoniste dei processi di implementazione all'interno di ciascun DSS, proprio per ottemperare agli impegni previsti quasi a scadenza del Piano che prevedono l'attivazione dei servizi. Quindi, proprio in questa fase, appare interessante provare a capire cosa stia accadendo al (o nel) DSS investito da questa spinta all'implementazione: la prospettiva qui adottata è quella di partire dalla narrazione che proprio i direttori/direttrici di Distretto ne fanno, considerando che la macro-articolazione distrettuale esemplifica il livello intermedio del sistema di responsabilità delle ASL che proprio nei processi di implementazione delle strategie aziendali gioca un ruolo cruciale (Embertson, 2006). Inoltre, come tutti i middle manager, essi rappresentano un anello fondamentale nella traduzione della strategia aziendale nella pratica per operatori (quali sono i professionisti) che riservano una certa inerzia alla sperimentazione dell'innovazione sui servizi (Birken *et al.*, 2012; 2018). Il fatto che tutte le ASL abbiano nel proprio orizzonte strategico l'attuazione del DM77/22 e del PNRR rappresenta una condizione unica nella storia dello sviluppo dei servizi territoriali. In questa prospettiva, è interessante esplorare il ruolo giocato dai direttori/direttrici e verificare come stanno interpretando il trasferimento di conoscenze e il coordinamento tra livelli organizzativi in un momento di pressione all'implementazione di strategie sovraordinate e aziendali (Boutcher *et al.*, 2022).

Quindi, alla luce della prospettiva qui adottata, il paragrafo 11.2 introdurrà obiettivi e metodi della ricerca condotta, mentre il paragrafo 11.2.1 descriverà l'adattamento ai direttori/direttrici di Distretto dell'approccio di Mintzberg alla lettura dell'attività ordinaria da loro condotta. Il paragrafo 11.3 descriverà i risultati dell'indagine e quello 11.4 li discuterà, illustrandone le implicazioni manageriali.

11.2 Obiettivi e Metodologia

La domanda di ricerca è la seguente: «Quali sono le differenze tra le missioni e i servizi dei DSS e le correlate attività svolte dai direttori/direttrici di distretto?». Si tratta di un interrogativo che aiuta a inquadrare gli sforzi che le ASL stanno compiendo per l'attuazione del DM77 e che può aiutare a comprendere sia i contenuti che il relativo processo di attuazione che ad esso si attribuiscono localmente (Cinelli *et al.*, 2023; Cinelli *et al.*, 2024). La prospettiva adottata, come già detto, mette al centro il ruolo dei direttori/direttrici di distretto, in quanto fonte primaria dei dati raccolti e in quanto attori chiave del processo di trasformazione dei servizi territoriali.

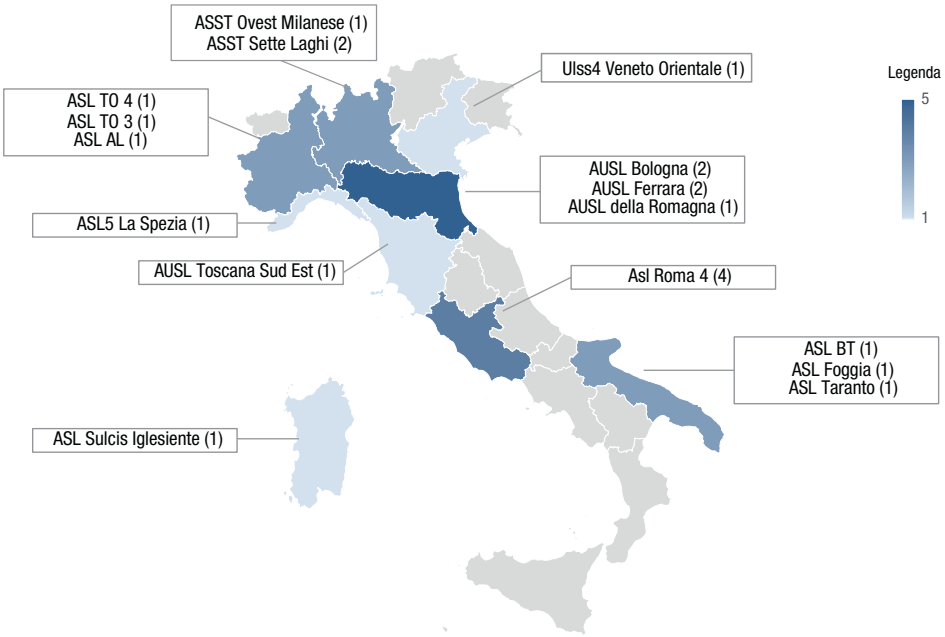
La risposta alla domanda di ricerca presuppone l'analisi di alcune caratteristiche tra le diverse realtà distrettuali. Quindi, risulta centrale comprendere: 1) come il DSS si inserisce nell'assetto organizzativo aziendale; 2) come i direttori/direttrici di DSS interpretano le attese nei confronti del loro ruolo; 3) quali sono i compiti e le attività della direzione del DSS.

La ricerca si colloca tra le attività 2025 del Network DiSS (direzioni di distretto sociosanitario), gestito da SDA Bocconi con il contributo non condizionante di Viatris. Il Network DiSS prevede incontri periodici di approfondimento di alcuni temi di rilevanza per le direzioni di DSS tramite discussione, analisi e confronto di esperienze italiane ed estere.

Sul piano metodologico, è stata condotta una survey composta da 38 domande (tempo di compilazione di circa 30 minuti), distribuita online tramite la piattaforma Qualtrics e organizzata in 4 sezioni per inquadrare le caratteristiche del DSS e l'interpretazione delle attese sul ruolo del direttore/direttrice[4]. A garanzia della qualità delle informazioni raccolte, sono stati organizzati molteplici momenti di confronto con i partecipanti al Network DiSS allo scopo di rendere chiare le domande, nella consapevolezza di una forte eterogeneità dei contesti di appartenenza e delle loro culture professionali. In uno degli incontri del Network DiSS è stato condiviso il testo della survey e alcune domande sono state modificate o riformulate in seguito al confronto con i partecipanti. La survey è stata distribuita a tutti i 25 partecipanti ed è rimasta aperta per la compilazione dal 18 aprile al 30 maggio 2025. Le risposte alle domande chiuse sono state analizzate tramite statistiche descrittive mentre per le risposte aperte sono state fatte analisi tematiche basate sulla frequenza dei contenuti con il supporto del software ChatGPT Education. La Figura 11.1 mostra il dettaglio dei 22 partecipanti alla survey, indicando la regione e l'azienda sanitaria dei DSS.

[4] Le quattro sezioni della survey hanno riguardato: 1) informazioni generali sul DSS; ii) profilo del direttore/direttrice di distretto; iii) assetto organizzativo del DSS; iv) ruoli e attese della direzione di DSS.

Figura 11.1 **Il campione delle direzioni di DSS che hanno risposto alla survey***



* La figura indica l'azienda in cui è collocato il DSS e, tra parentesi, il numero di DSS per azienda.
Fonte: elaborazione degli autori

Per ricostruire le attività che compongono l'agenda dei direttori/direttrici di distretto è stato chiesto ai 25 partecipanti al Network DiSS di condividere la loro agenda relativa alla settimana lavorativa del 19-23 maggio 2025, che i partecipanti hanno confermato poter essere sufficientemente rappresentativa della loro quotidianità (ad esempio, per assenza di impegni straordinari come convegni o viaggi di lavoro). Le informazioni sulle agende sono state raccolte tramite la compilazione di una scheda in formato Excel, testata con una rilevazione pilota da parte di due partecipanti nella giornata dell'8 maggio 2025. La scheda è stata condivisa con tutti i partecipanti, insieme a un documento con le istruzioni di compilazione e alcuni esempi[5]. La Tabella 11.1 mostra un esempio di scheda di rilevazione delle agende.

Sono state analizzate 16 agende. Le informazioni raccolte sono state riclassificate secondo le 10 categorie di Mintzberg presentate nel paragrafo successivo.

[5] Nel file è stato richiesto di inserire, alla fine di ogni giornata lavorativa, le seguenti informazioni: 1) tipo di attività svolta (es. riunione, workshop, incontro, e-mail, chiamata, sopralluogo); 2) stakeholder coinvolti; 3) oggetto dell'attività; 4) obiettivo dell'attività; 5) descrizione del ruolo avuto nell'attività; 6) se l'attività era programmata o è emersa nel corso della giornata; 7) se l'attività si è svolta in presenza o online.

Tabella 11.1 **Esempio di scheda di rilevazione delle agende**

Orario	Tipo di attività	Stakeholder coinvolti (se presenti)	Oggetto	Obiettivo	Dettagli sui contenuti e ruolo svolto	Programmato / Non programmato	In presenza / Virtuale
8:00-8:30	Riunione	MMG e Dipartimento Cure primarie	Coinvolgimento dei MMG nella Casa della Comunità	Discutere orari, gestione delle agende e modalità di coinvolgimento	Ho dovuto gestire il conflitto tra alcuni MMG e mediare con il DCP per trovare una soluzione	Programmata	In presenza

Fonte: elaborazione degli autori

Ciascuna agenda è stata riclassificata da tre ricercatrici che in parallelo hanno condotto l'analisi, confrontandosi sulle scelte per verificarne la coerenza interpretativa, discutere delle discordanze e chiarire i significati da attribuire a ciascuna attività rilevata. A seguito della riclassificazione è stata condotta un'analisi statistica di tipo descrittivo. Infine, i risultati emersi sono stati discussi e validati durante un workshop con i partecipanti del Network DiSS.

11.2.1 L'approccio di Mintzberg adattato ai direttori/direttrici di DSS

Uno dei tentativi più noti di dare senso al caos apparente che caratterizza l'attività quotidiana dei manager è stato compiuto da Henry Mintzberg nel 1971 (pubblicato poi nel 1973). Egli condusse uno studio approfondito su un gruppo di alti dirigenti, documentando sistematicamente tutte le loro attività, la corrispondenza e i contatti intrattenuti durante il periodo di osservazione. Il lavoro nacque in parte come risposta critica alle teorie manageriali tradizionali: Mintzberg metteva in dubbio l'adeguatezza delle classiche «funzioni» del management (pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo) definite da Fayol (1916) per descrivere ciò che i manager facevano davvero. Dopo aver osservato la routine mattutina, Mintzberg si domandò provocatoriamente: *«Quali di queste attività si possono chiamare pianificazione, organizzazione, coordinamento, controllo? […] In realtà, queste parole non descrivono affatto il lavoro reale dei manager»* (Tengblad e Vie, 2012). Dalla sua analisi emerse, infatti, un quadro del lavoro manageriale molto diverso dalla teoria classica: l'attività del manager si rivelò altamente frammentata, con un'enfasi maggiore sulla gestione di problemi quotidiani emergenti che sulla pianificazione di lungo termine; inoltre, i manager dedicavano sorprendentemente più tempo alla comunicazione verbale informale che a quella scritta, e quasi la metà del tempo nelle riunioni risultò speso in incontri con i subordinati (il resto con superiori, colleghi e soggetti esterni) (Lega *et al.*, 2022).

Numerosi studi successivi hanno testato e applicato il suo approccio in vari contesti aziendali e in diversi settori. Tengblad (2006) replicò l'analisi sui dirigenti d'azienda per verificare se il lavoro manageriale fosse cambiato: emerse un modello di comportamento in cui molte caratteristiche individuate da Mintzberg rimanevano valide, sebbene con alcune differenze dovute all'evoluzione del contesto. In particolare, Tengblad riscontrò un carico di lavoro ancora maggiore per i top manager contemporanei, un lavoro meno frammentato e meno interrotto rispetto al passato, meno attività amministrative d'ufficio e più tempo dedicato ad aspetti di rappresentanza formale. In seguito, un ampio studio internazionale di Bandiera *et al.* (2020) confermò che i CEO dedicano circa il 70% del tempo alle interazioni con altri soggetti, soprattutto interni, e solo il 20% circa con stakeholder esterni. Sono state esplorate con il modello di Mintzberg anche differenze tra manager di settori diversi: Johnson e Dobni (2016) evidenziarono che il lavoro dei dirigenti apicali nel settore pubblico aveva forti analogie con quello nel settore privato. Sempre Johnson e Dobni evidenziarono su quattro aziende sanitarie canadesi che le attività e responsabilità dei top manager pubblici riflettevano in gran parte quelle dei loro omologhi nel privato, suggerendo che le competenze manageriali siano in buona misura trasferibili tra i due ambiti.

Come negli esempi riportati, la riflessione sul ruolo dei direttori/direttrici di distretto parte da alcuni degli assunti dell'approccio di Mintzberg: egli, infatti, concluse che i manager, nel loro lavoro quotidiano, ricoprono dieci ruoli fondamentali, ovvero schemi di comportamento tipici. Tali ruoli manageriali sono raggruppati in tre categorie più ampie – ruoli interpersonali, informativi e decisionali – a seconda della natura prevalente delle attività:

- **Ruoli interpersonali:** derivano dall'autorità formale e dalle relazioni che il manager deve intrattenere. Comprendono il ruolo di rappresentante simbolico (*figurehead*) in virtù della posizione gerarchica, quello di *leader*/guida verso i collaboratori (motivatore e guida, conciliando esigenze organizzative e bisogni individuali) e il ruolo di collegamento/interfaccia (*liaison*) nelle relazioni orizzontali. In quest'ultimo caso, il manager sviluppa e mantiene una rete di contatti esterni all'organizzazione, interagendo in modo formale e informale a vari livelli gerarchici. Questi ruoli interpersonali sono spesso quelli in cui il manager è più visibile, poiché attraverso di essi egli rappresenta l'organizzazione e ne incarna la leadership.
- **Ruoli informativi:** sono connessi al trattamento e alla diffusione delle informazioni. In base alle osservazioni fatte, Mintzberg evidenziò che il manager agisce da *monitor* o osservatore attivo, raccogliendo e filtrando costantemente informazioni sull'andamento interno ed eventi esterni rilevanti per l'azienda. Egli svolge poi il ruolo di diffusore/comunicatore interno (*disseminator*), trasmettendo a collaboratori interni e subordinati le informazioni ne-

cessarie affinché possano svolgere al meglio il loro lavoro. Infine, il manager funge da portavoce (*spokesperson*) verso l'esterno, dovendo rappresentare e comunicare informazioni sull'organizzazione a interlocutori esterni (come i cittadini, i media, partner o enti di controllo) e ai livelli gerarchici superiori. In sintesi, il manager filtra, condivide e comunica informazioni critiche, assicurandosi al contempo dell'accuratezza e affidabilità di tali informazioni. In questa classe di attività rientrano anche quelle relative al suo aggiornamento e alla sua formazione relativa alle dinamiche interne ed esterne dell'azienda.

- **Ruoli decisionali:** sono attinenti all'assunzione di decisioni e all'uso dell'autorità per allocare risorse e affrontare situazioni. Mintzberg sottolineò che decidere è parte cruciale dell'attività manageriale, declinata in quattro ruoli decisionali principali. Come imprenditore/innovatore o iniziatore del cambiamento (*entrepreneur*), il manager identifica opportunità, promuove progetti e innovazioni, e prende l'iniziativa di migliorare processi e risultati aziendali – un ruolo proattivo di pianificazione e sviluppo. Nel ruolo di gestore delle criticità (*disturbance handler*) il manager reagisce a eventi imprevisti e problemi urgenti che sfuggono al controllo, contenendo le crisi e ripristinando l'equilibrio – un ruolo essenzialmente reattivo di problem-solving straordinario. Vi è poi il ruolo di allocatore di risorse (*resource allocator*), in cui il manager deve decidere come distribuire risorse limitate – denaro, personale, tempo, attrezzature – tra diversi progetti o unità, programmando le attività ordinarie, la gestione operativa e autorizzando le azioni dei collaboratori. Infine, come negoziatore (*negotiator*), il manager rappresenta l'organizzazione in trattative e negozia accordi con parti interne o esterne, prendendo decisioni circa gli impegni da assumere e le concessioni possibili in tali negoziati.

È importante notare che i manager non dedicano a questi ruoli lo stesso tempo né li svolgono tutti con la medesima frequenza: a seconda del livello organizzativo, del settore e del momento, possono emergere ruoli dominanti o prioritari differenti da manager a manager. Inoltre, la stessa attività può prevedere l'adozione di più ruoli contemporaneamente, per esempio un manager può raccogliere informazioni (osservatore attivo – ruolo informativo) al fine di prendere decisioni su come allocare le risorse o gestire una situazione critica (ruolo decisionale). In alcuni incarichi prevalgono i ruoli interpersonali (si pensi a un direttore generale come rappresentante pubblico dell'ente), in altri quelli decisionali o informativi; inoltre, il mix di ruoli può cambiare in situazioni di emergenza rispetto alla routine. Ciò che Mintzberg mostrò fu che, sebbene tutti i manager svolgessero in una certa misura questi dieci ruoli, il contesto e le caratteristiche specifiche del ruolo influenzavano alcuni rispetto ad altri. Nella Tabella 11.2 di seguito si riportano alcuni esempi dei ruoli descritti da Mintzberg, ma applicati ai direttori e direttrici di distretto.

Tabella 11.2 **I ruoli manageriali di Mintzerg: una classificazione**

Categoria	Ruolo Mintzberg	Esempio nell'ambito dei Distretti
Interpersonali	**1. Rappresentante simbolico** (*Figurehead*)	Partecipa a incontri o cerimonie ufficiali (es. inaugurazione di una nuova RSA, rappresentanza del DSS ai tavoli regionali), firma documenti ufficiali (protocolli con Comuni, delibere).
	2. Leader / Guida	Coordina l'équipe distrettuale, motiva gli operatori, valuta la performance.
	3. Collegamento / interfaccia (*Liason*)	Partecipa a momenti di confronto/riunioni con attori, ad esempio, enti locali, cooperative sociali o associazioni di volontariato per coordinare servizi integrati.
Informativi	**4. Osservatore attivo** (*Monitor*)	Partecipa a incontri di presentazione di piani e strategie e a corsi di formazione, analizza gli indicatori di salute territoriale, riceve report da responsabili di servizi, valuta l'andamento dei piani di assistenza individuale.
	5. Diffusore / comunicatore interno (*Disseminator*)	Trasmette linee guida regionali o aziendali agli operatori, comunica modifiche organizzative, aggiorna il team su risultati di audit clinici.
	6. Portavoce (*Spokesperson*)	Riporta alla Direzione Generale l'andamento dei servizi del distretto, relaziona sull'impatto dei progetti di integrazione sociosanitaria all'esterno.
Decisionali	**7. Imprenditore / innovatore (***Entrepreneur*)	Propone progetti di presa in carico multidisciplinare, sviluppa nuovi servizi, introduce strumenti digitali (cartelle elettroniche, telemedicina).
	8. Gestore delle crisi (*Disturbance Handler*)	Interviene in situazioni di conflitto tra operatori, gestisce emergenze organizzative (es. sospensione di servizi, carenze di personale).
	9. Allocatore di risorse (*Resource Allocator*)	Decide come assegnare fondi a progetti distrettuali, distribuisce personale tra i servizi, gestisce i turni e il budget.
	10. Negoziatore (*Negotiator*)	Negozia convenzioni con MMG/PLS, negozia il budget del DSS, accordi con enti del terzo settore, risolve richieste sindacali interne.

Fonte: elaborazione degli autori su Mintzberg (1973)

Mintzberg, inoltre, individuò sei caratteristiche ricorrenti del lavoro manageriale. 1) **Ritmo intenso:** i manager svolgono un'elevata quantità di lavoro a un ritmo incessante, con pressioni di tempo costanti. Spesso la loro agenda è fitta e richiede di passare rapidamente da un compito all'altro senza soste prolungate. 2) **Varietà e frammentazione:** l'attività manageriale è estremamente varia e frammentata in compiti di breve durata. Le giornate del manager spaziano tra molti argomenti diversi e avvengono frequenti interruzioni; raramente può concentrarsi a lungo su una singola attività. 3) **Preferenza per l'azione e l'adattamento ad hoc**: i manager tendono a focalizzarsi su questioni attuali, concrete e specifiche, prediligendo problemi immediati e non routinari rispetto alla pianificazione astratta di lungo periodo. C'è dunque un orientamento pratico all'azione rapida e alla risoluzione di problemi contingenti. 4) **Network di contatti**: il manager funge da nodo di collegamento tra l'organizzazione e una rete di contatti esterni. Per svolgere il proprio ruolo deve mantenere comunicazioni costanti non solo con i membri interni (superiori, pari grado, collaboratori) ma anche con clienti, fornitori, partner e altri stakeholder esterni. Tramite questa rete informale di relazioni ottiene informazioni dall'ambiente e rappresenta l'organizzazione verso l'esterno. 5) **Comunicazione prevalentemente verbale**: i

manager mostrano una marcata preferenza per i mezzi di comunicazione orali e personali. Gran parte delle informazioni e decisioni vengono scambiate tramite conversazioni faccia a faccia, telefonate, riunioni, più che mediante relazioni scritte o email formali. Questa preferenza è legata anche alla necessità di ottenere *feedback* immediato e alla natura spesso ambigua dei problemi manageriali, che richiede dialogo interpersonale più che modulistica. 6) **Controllo e autonomia personale**: nonostante la mole di obblighi e vincoli, il manager appare in grado di esercitare un certo controllo sulla propria agenda e sulle modalità con cui svolge le attività. In virtù della sua posizione, egli ha margine di autonomia nel definire priorità, nel delegare compiti e nel negoziare risorse. In altri termini, il dirigente "sceglie come adempiere ai propri doveri", potendo in parte plasmare il ruolo secondo il proprio stile pur entro le responsabilità assegnate.

Mintzberg ha contribuito a sfatare alcuni miti sulla figura del manager: ad esempio, quello del manager che pianifica razionalmente a porte chiuse, o che delega ogni attività operativa. Al contrario, *"studio dopo studio ha mostrato che i manager lavorano a un ritmo incessante, con attività caratterizzate da brevità, varietà e discontinuità"* (Mintzberg 1990); il manager è immerso nell'azione continua e comunica costantemente, più come un *regista sul campo* che come un pianificatore distaccato.

11.3 Risultati

11.3.1 Le caratteristiche dei DSS e dei direttori/direttrici di DSS

Le caratteristiche territoriali dei DSS

In termini di bacino di utenza, i 22 DSS analizzati ricalcano, nella maggior parte dei casi, la popolosità media prevista dal DM77/22 (un Distretto ogni 100mila abitanti). Infatti, il 59% dei DSS ha una popolazione tra 50.000 e 100.000 abitanti e il 23% tra 100.000 e 150.000, mentre il 14% ne ha più di 200.000 e il 5% meno di 50.000. Sia l'estensione del territorio di riferimento del DSS che la numerosità dei Comuni compresi variano a seconda della tipologia di territorio su cui insiste il Distretto (Tabella 11.3). Il numero di Comuni presenti nei DSS, infatti, varia sensibilmente da un minimo di 1 ad un massimo di 65, con una media di 13. I DSS che insistono su aree metropolitane o urbane hanno una media di 7 Comuni nel loro territorio, mentre sale a 21 il numero medio quando il DSS è extraurbano, montano o insulare. L'estensione del territorio di competenza dei DSS è in media di 375 km^2 per quelli metropolitani o urbani e di 568 km^2 per quelli in aree extraurbane, montane o insulari. Tali caratteristiche si riflettono anche sulla distribuzione della popolazione: più densamente distribuita nelle aree metropolitane o generalmente urbane, poco o pochissimo popolose quelle extra urbane, presentando bisogni diversi e risposte differenti in termini di servizi e infrastrutture.

Tabella 11.3 **Numero di Comuni e superficie di competenza dei DSS (valore medio, minimo e massimo, e per tipologia di territorio)**

	Media	Minimo	Massimo	Media aree metropolitane o urbane	Media aree extraurbane, montane o insulari
Numero di Comuni	13	1	65	7	21
Superficie di competenza (km^2)	463	76	1.398	375	568

Fonte: elaborazione degli autori su dati survey

L'assetto organizzativo dei DSS

Il 50% dei DSS analizzati dipende gerarchicamente dalla Direzione Generale dell'ASL, mentre il 27% da quella Sanitaria e il restante 23% dalla Direzione Socio-Sanitaria. Al di là della relazione privilegiata con membri diversi della direzione strategica, la diversa dipendenza gerarchica inquadra in modo differente la funzione e gli obiettivi del DSS. Se nel primo caso la direzione di DSS interpreta quelli della Direzione Generale nei singoli territori, nel secondo caso sono più legati alla relazione coi professionisti e ai temi del governo clinico. Più difficile è cogliere le implicazioni della dipendenza dalla Direzione Socio-Sanitaria, che viene interpretata in modo diverso nei diversi contesti regionali, ma che in prima battuta propone una maggiore enfasi sull'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e quelli socioassistenziali.

L'82% dei direttori/direttrici di Distretto dirige una U.O. complessa, mentre negli altri casi il ruolo di direttore/direttrice di Distretto prevede un contratto libero professionale con incarico individuale a tempo determinato e indennità equivalente a quello di direzione di dipartimento, o indennità parziale. Nel 50% dei DSS analizzati esistono delle strutture organizzative che da esso dipendono, definite prevalentemente per setting, quali ad esempio Consultorio Familiare, Cure Primarie, Sanità Penitenziaria, Cure Palliative, Hospice, Cure Domiciliari, PUA, Case della Comunità, Presidi Poliambulatoriali, e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali.

Per quanto riguarda il personale che opera nel DSS, occorre precisare che in media il 41% dipende da altre strutture aziendali diverse dal DSS, mentre il 33% dipende dal DSS o da sue articolazioni e il 26% è fatto da personale non dipendente o convenzionato. Quindi, in media, le attività del DSS sono svolte in misura minoritaria da dipendenti del DSS e in alcuni casi il personale che dipende da altre strutture aziendali arriva a rappresentare la totalità degli operatori del Distretto.

Il 73% dei DSS analizzati si configura come centro di responsabilità[6] nei

[6] Per centro di responsabilità si intende un'unità organizzativa all'interno dell'azienda, alla quale sono assegnati specifici obiettivi e le risorse necessarie per raggiungerli. Il responsabile del

sistemi di programmazione e controllo aziendali e nel 44% di questi vi sono centri di responsabilità sub-distrettuali largamente identificati per setting di offerta, quali ad esempio Consultorio Familiare, Centri Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), Specialistica Ambulatoriale, Cure Domiciliari, e Punti Prelievo.

Tutti i DSS analizzati hanno degli obiettivi annuali, e la loro negoziazione coinvolge spesso più membri della direzione strategica e degli staff: nel 64% dei casi coinvolge il Direttore/Direttrice Generale, nel 23% quello/a Socio-Sanitario, nel 18% il Direttore/Direttrice Sanitario e nel 23% altre figure, tra cui il responsabile del Controllo di Gestione e il Direttore Amministrativo. Nel 9% dei casi gli obiettivi non vengono propriamente negoziati, ma sono il ribaltamento di quelli della direzione generale. In media, per il 29% si tratta di obiettivi economici, legati a tempi di liquidazione delle fatture, al fondo regionale per la non autosufficienza, ai tetti di spesa farmaceutica convenzionata e all'uso delle risorse per gli inserimenti in strutture. Per il resto, si tratta di obiettivi non economici, legati a dimissioni protette, allo sviluppo e organizzazione delle Case della Comunità, allo sviluppo dei LEPS, alla quota di pazienti in cure domiciliari, alle liste di attesa, e implementazione di CAU e COT.

Il 68% dei DSS dichiara di avere autonomia economico-finanziaria, percentuale che coincide quasi perfettamente con i DSS configurati come centro di responsabilità. Il budget del Distretto rappresenta un ulteriore ambito di negoziazione, e coinvolge anch'esso molteplici membri della direzione strategica e degli staff. Il budget è infatti negoziato nel 67% dei casi con il Direttore/Direttrice Generale, nel 40% con il Controllo di Gestione, nel 20% con il Direttore/Direttrice Sanitario e nel 13% con il Direttore/Direttrice Socio-Sanitario. L'80% dei DSS analizzati utilizza parte del budget per beni e servizi (ad es., sedi distrettuali, veicoli, pc, software), il 53% dei DSS ne impiega parte per progetti territoriali del Distretto, il 47% dei DSS per attività specifiche (ad es., ADI, specialistica ambulatoriale), il 33% dei DSS per contratti e convenzioni e il 13% dei DSS per risorse umane assegnate al Distretto.

Il profilo dei direttori/direttrici di DSS

Nel campione osservato vi è una prevalenza di direttrici (59%). L'età media dei direttori/direttrici è di 56 anni (con un minimo di 42 fino ad un massimo di 65 anni). Essi hanno prevalentemente una formazione in Medicina, nel 64% dei casi, seguita da scienze infermieristiche nel 14% dei casi. Ulteriori aree di formazione includono altre professioni sanitarie, comunicazione, economia, scienze biologiche e sociologia. Nel 45% dei casi i direttori e le direttrici hanno conseguito, come titolo di studio più elevato, un master universitario di II livel-

centro ha l'autorità e la responsabilità di gestire tali risorse in modo efficiente ed efficace, ed è valutato in base al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

lo, nel 32% dei casi una laurea a ciclo unico o specialistica, nel 14% dei casi una specializzazione in medicina e un dottorato nel restante 9% dei casi.

Come evidenzia la Tabella 11.4, direttori e direttrici hanno una lunga esperienza nel SSN (pari mediamente a 27 anni) con valori che vanno da un minimo di 9 ad un massimo di 39 anni. Agiscono il ruolo di direttori/direttrici di distretto in media da 5 anni (con un minimo di 2 e un massimo di 14 anni). Circa il 70% ha ricoperto tale ruolo unicamente nel DSS che attualmente dirige: in dettaglio, essi sono direttori/direttrici del DSS che guidano in questo momento in media da 4 anni (con un minimo di 1 e un massimo di 8 anni). Nel ricoprire tale ruolo, il 9% lo è ad interim / facente funzione, mentre il 91% è in ruolo. Elemento significativo è che, nel 14% dei casi, direttori/direttrici di Distretto ricoprono anche altre posizioni (ad esempio, Responsabile della UOSD Screening Oncologici, Coordinatore dell'Area Territoriale e Direttore delle Attività Socio-Sanitarie).

Tabella 11.4 **Età ed esperienza lavorativa dei Direttori e delle Direttrici di DSS (valore medio, minimo e massimo)**

	Media	Minimo	Massimo
Età (anni)	56	42	65
Esperienza lavorativa nel SSN (anni)	27	9	39
Tempo trascorso nel ruolo di direttore/direttrice di DSS (anni)	5	2	14
Tempo trascorso alla Direzione del DSS attuale (anni)	4	1	8

Fonte: elaborazione degli autori su dati survey

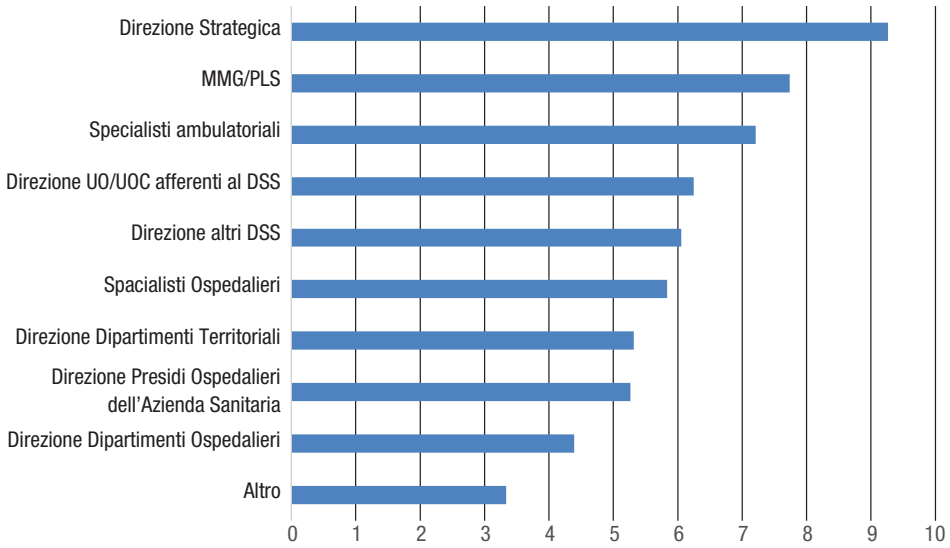
11.3.2 Le prospettive dei direttori/direttrici di DSS

Quali percezioni rispetto agli stakeholder interni?

Le risposte della survey (riportate nella Figura 11.2) permettono di comprendere quali stakeholder interni siano considerati più rilevanti dalle direzioni di DSS[7] e mostrano come la direzione strategica sia lo stakeholder di maggior rilievo (valore medio 9,26), seguito da MMG/PLS (7,74) e dagli specialisti ambulatoriali (7,21). Gli stakeholder considerati come meno rilevanti sono le Direzioni dei Dipartimenti ospedalieri (4,39), le Direzioni dei Presidi Ospedalieri dell'azienda sanitaria (5,26) e le Direzioni dei Dipartimenti Territoriali (5,32).

[7] Ai rispondenti è stato chiesto, usando una scala Likert da 0 a 10 (dove 0 = per nulla rilevante e 10 = molto rilevante), di indicare quanto fossero rilevanti gli stakeholder del DSS interni all'azienda. I risultati delle risposte sono calcolati come il valore medio delle risposte per ciascuno stakeholder. Come anticipato nella sezione di metodologia, l'elenco degli stakeholder interni è stato definito sulla base di un lavoro di gruppo svolto in un precedente workshop del Network DiSS.

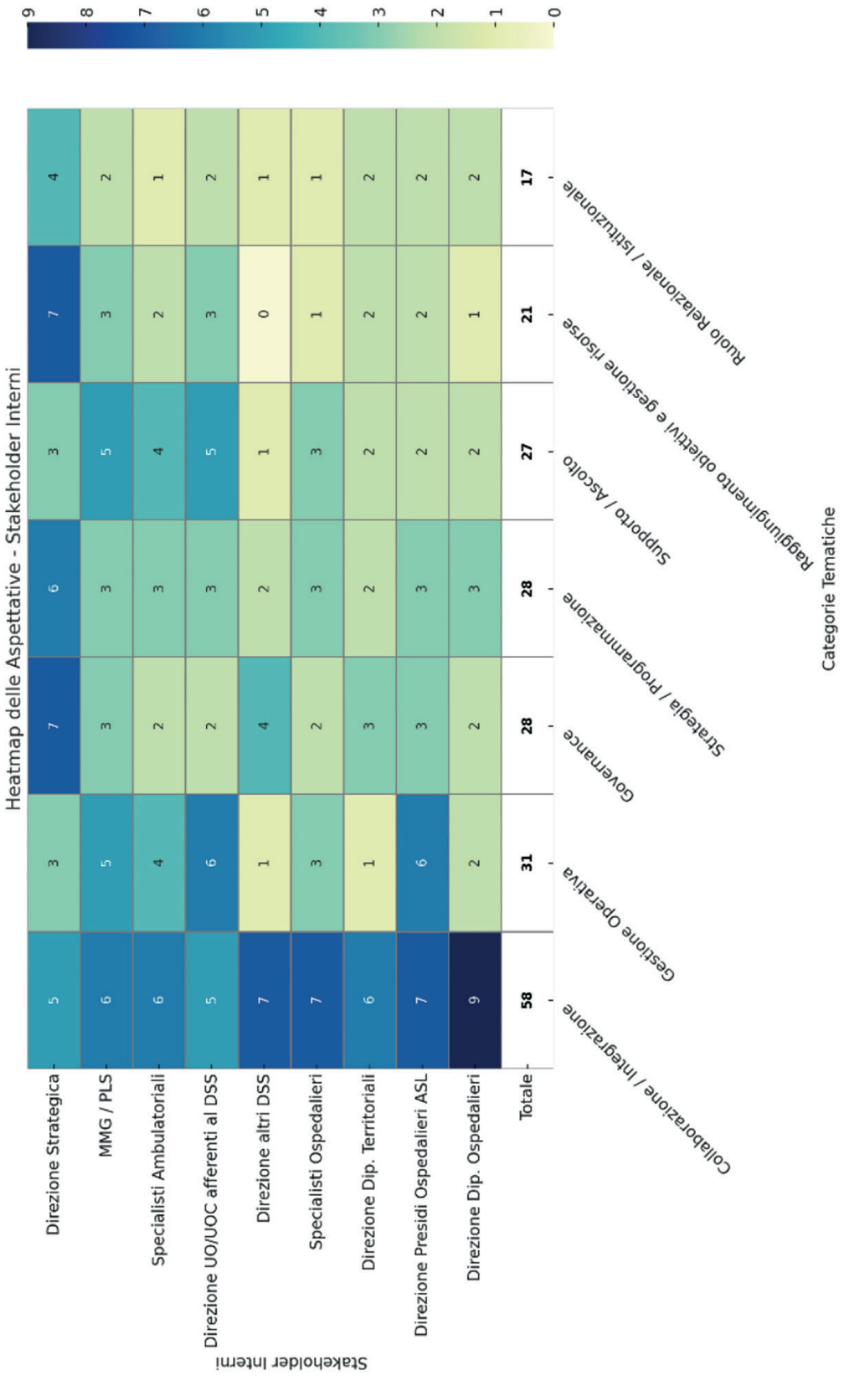
Figura 11.2 **Rilevanza degli stakeholder del Distretto interni all'azienda (n=19)**



Fonte: elaborazione degli autori su dati survey

Ai rispondenti è successivamente stato chiesto di descrivere le aspettative che ciascuno degli stakeholder interni nutre nei loro confronti, riassumibili in 7 categorie tematiche: a) collaborazione e integrazione; b) gestione di attività operative; c) governance (intesa come autonomia dei processi decisionali del DSS); d) strategia e programmazione; e) supporto e ascolto; f) raggiungimento obiettivi e gestione risorse; g) ruolo relazionale e istituzionale. Le aspettative maggiormente rilevate riguardano la categoria di "Collaborazione e integrazione" (citata 58 volte) che si riferisce alle aspettative di coordinamento interprofessionale in capo alla direzione di DSS, alimentate principalmente dagli attori della rete ospedaliera (direttori dei dipartimenti ospedalieri e specialisti ospedalieri). Questa categoria include l'integrazione dei percorsi attraverso setting della filiera territoriale e ospedaliera: *"Collaborazione per il governo dei processi e per l'integrazione dei servizi socio-sanitari", "Definizione di percorsi condivisi tra ospedale e territorio", "Facilitare l'integrazione tra MMG, specialisti e servizi ospedalieri", "Interfaccia con Direttori Dipartimenti Territoriali, Direzione Strategica per percorsi integrati"*. La seconda categoria più frequentemente rilevata riguarda le aspettative di "Gestione operativa" legata soprattutto alla risoluzione di specifici casi (citata 31 volte) che richiedono alla direzione di DSS la gestione di problemi logistici, gestionali o organizzativi, come: *"Dimissioni protette e riammissioni (organizzazione post-acuzie)", "Funzionamento PUA e percorsi post-ricovero", "Implementazione di processi organizzativi per garantire il passaggio tra setting ospedaliero e territo-*

Figura 11.3 **Aspettative degli stakeholder interni**



Fonte: elaborazione degli autori su dati survey

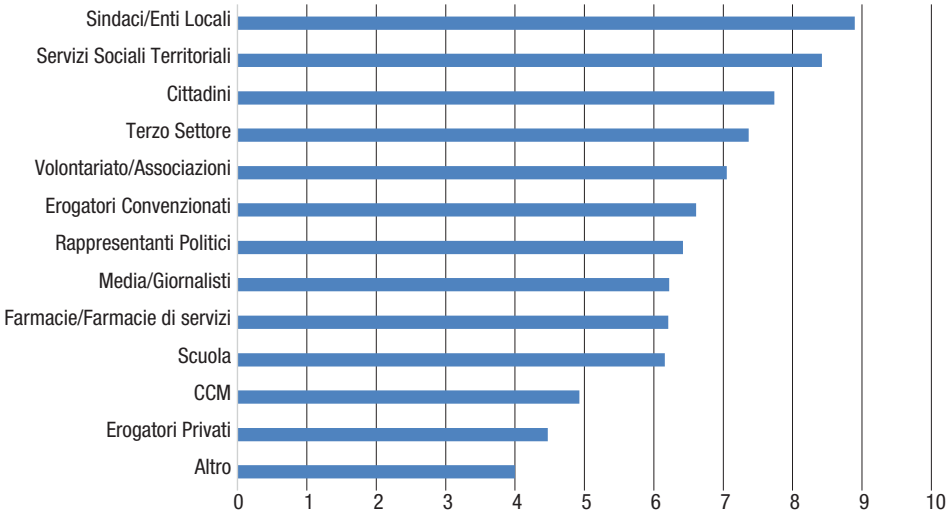
riale", "Gestione degli slot per prestazioni specialistiche dopo la dimissione", "Gestione problematiche legate ai bed blockers". Queste aspettative arrivano principalmente dai direttori dei presidi ospedalieri e delle UU.OO. distrettuali. Le attese relative ai ruoli di "Governance" e "Strategia/programmazione" sono citate 28 volte ciascuna. "Governance" è una categoria di aspettative che deriva principalmente dalla relazione più o meno intensa con la direzione strategica aziendale e si riferisce al ruolo di autonomia dei processi decisionali del DSS nell'indirizzo e coordinamento dei servizi: *"Governare i principali servizi nel territorio", "Governo dei processi", "Governo della medicina generale"*. La categoria di "Strategia/Programmazione" include le attese rispetto alla capacità della direzione di DSS di tradurre gli indirizzi strategici in programmazione operativa: *"Attuazione del DM 77/2022", "Definizione di indirizzi e strategie locali", "Tradurre gli obiettivi regionali in azioni distrettuali concrete"*. Le aspettative di "Supporto/ascolto" (27 citazioni) si riferiscono alla gestione delle persone e delle relazioni tra professionisti interni al DSS o all'azienda. Comprende il supporto nella risoluzione di criticità e conflitti: *"Presenza attiva e capacità di ascolto rispetto a carenze di personale", "Supporto nella risoluzione dei problemi operativi", "Punto di riferimento nei rapporti con MMG e servizi sociali", "Valorizzazione delle competenze professionali"*. La categoria "Raggiungimento obiettivi e gestione risorse" (21 citazioni) include le attese rispetto a obiettivi aziendali, spesso derivanti dalla direzione strategica *"Rispetto del budget e degli indicatori di performance", "Efficienza e appropriatezza nella gestione delle risorse"*. Infine, il "Ruolo relazionale/istituzionale" (17 citazioni) racchiude le attese che vedono il DSS come interfaccia tra l'azienda e gli attori esterni e includono la capacità di rappresentare l'azienda, di negoziare e creare alleanze strategiche: *"Interfaccia con i Sindaci", "Gestione dei rapporti con stakeholder esterni all'Azienda", "Dialogo proattivo con la comunità locale e le istituzioni", "Ascolto dei bisogni del territorio e co-progettazione"*.

Quali percezioni rispetto agli stakeholder esterni?

Lo stesso approfondimento sulle aspettative verso i direttori e le direttrici dei DSS è stato replicato per gli stakeholder esterni. Gli stakeholder esterni all'azienda che emergono come più rilevanti per i direttori/direttrici di distretto sono i sindaci e i referenti degli gli enti locali (8,89) i professionisti dei servizi sociali territoriali (8,42) e i cittadini (7,74). Gli stakeholder considerati come meno rilevanti sono gli erogatori privati (4,47), i comitati consultivi misti (dove presenti) (4,93) e le scuole sono in una sorta di posizione intermedia (6,16).

Le aspettative dei 12 stakeholder esterni verso la direzione di DSS sono riassumibili nelle 6 categorie tematiche seguenti: i) Collaborazione/Co-progettazione; ii) accessibilità e prestazioni dei servizi; iii) integrazione Socio-Sani-

Figura 11.4 **Rilevanza degli stakeholder del Distretto esterni all'azienda (n=19)**

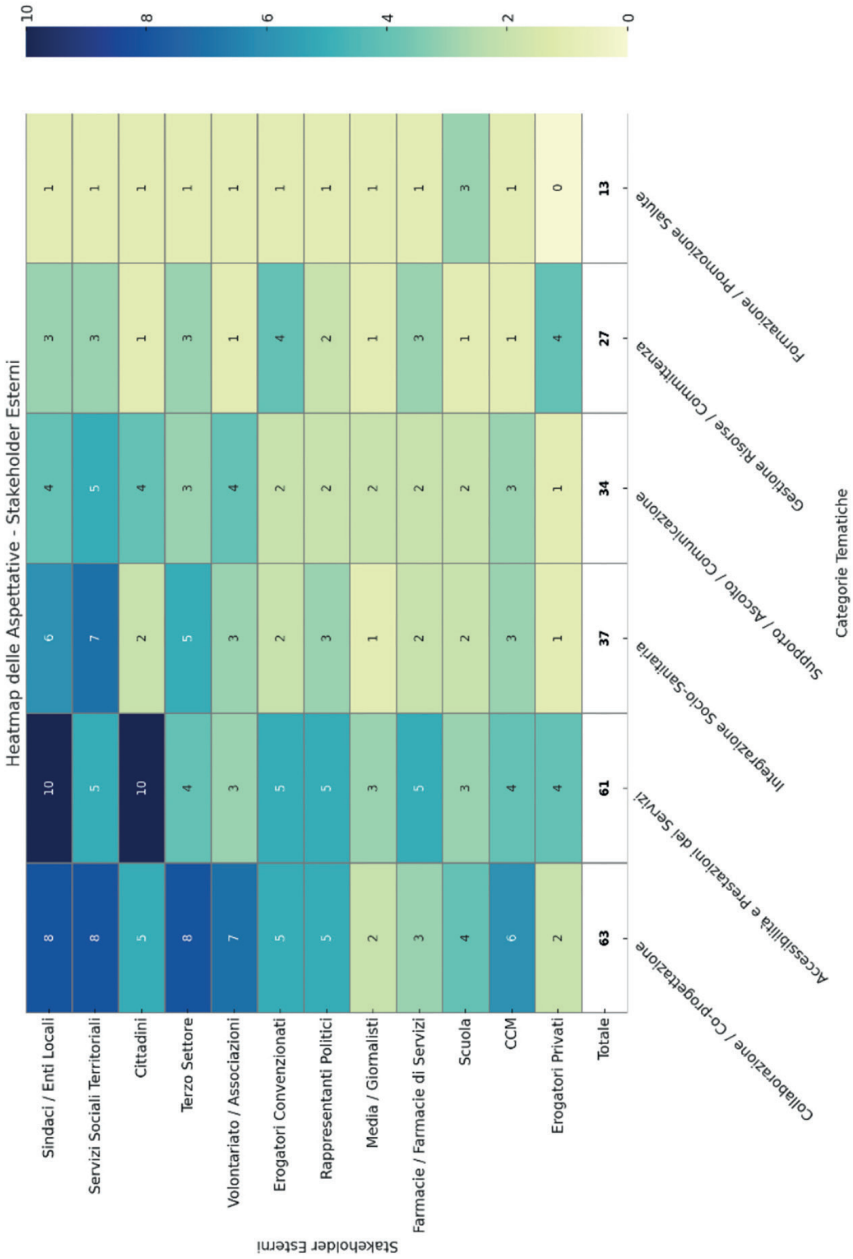


Fonte: elaborazione degli autori su dati survey

taria; iv) supporto/ascolto/comunicazione; v) gestione risorse/committenza; vi) formazione/promozione salute.

La più frequentemente citata riguarda "Collaborazione/Co-progettazione" (63 citazioni) e include le attese rivolte da sindaci o enti locali, terzo settore, volontariato, associazioni e servizi sociali, che si aspettano dal DSS di essere coinvolti in tavoli decisionali per la definizione condivisa delle priorità strategiche e nella programmazione, definizione e gestione dei servizi: *"Coinvolgere gli enti del terzo settore presenti sul territorio", "Collaborare con il volontariato per offrire supporto emotivo e pratico ai pazienti", "Partecipare alla programmazione condivisa dei servizi".* Vengono riportate aspettative nei confronti del DSS da parte di sindaci/enti locali e cittadini riguardo all'"Accessibilità e prestazioni dei servizi" (61 citazioni), con riferimento alla disponibilità e tempestività dei servizi: *"Garantire servizi di prossimità non solo nelle Case di Comunità ma anche nei diversi Comuni", "Soddisfacimento dei bisogni in tempi rapidi, avere servizi di prossimità nei diversi Comuni", "Riduzione dei tempi di attesa, facilità di accesso alle cure", "Erogare idonea assistenza sanitaria ai cittadini".* Le aspettative rispetto all'"Integrazione Socio-Sanitaria" (37 citazioni) sono rivolte ai DSS principalmente da membri dei servizi sociali, sindaci/enti locali e terzo settore e fanno riferimento alla capacità della direzione di DSS di promuovere e favorire l'integrazione tra servizi sanitari e sociali: *"Integrazione socio-sanitaria tra Sindaci, enti locali e servizi sociali", "Promuovere l'integrazione socio-sanitaria, collaborare alla programmazione dei Piani di Zona".* La terza categoria più fre-

Figura 11.5 **Aspettative degli stakeholder esterni**



Fonte: elaborazione degli autori su dati survey

quentemente rilevata riguarda il ruolo di "Supporto/Ascolto/Comunicazione" (34 citazioni) della direzione di DSS, con riferimento all'ascolto delle istanze dei vari attori, alla disponibilità al confronto su questioni rilevanti e al mantenimento della comunicazione e dello scambio di informazioni: *"Ascolto dei bisogni del territorio e dialogo proattivo", "Confronto con i cittadini", "Tempestività nelle informazioni", "Informazione e interlocuzione costante"*. Alcune aspettative riguardano la "Gestione risorse/Committenza" (27 citazioni), principalmente riportate con riferimento agli erogatori privati e convenzionati, in merito alla capacità del DSS di allocare risorse e stipulare accordi: *"Pagamento delle prestazioni in tempi brevi", "Gestione della committenza, prestazioni e visibilità"*. Infine, l'ultima categoria di aspettative degli stakeholder esterni, principalmente delle scuole, riguarda "Formazione/Promozione Salute" (13 citazioni) e si riferisce a: *"Sviluppo di progetti di prevenzione e contrasto (abbandono scolastico, dipendenze...)", "Formazione e aggiornamento su temi sanitari emergenti", "Promuovere la salute e la prevenzione tra gli studenti"*.

I rispondenti alla survey hanno poi esplicitato le aspettative che, nella loro percezione, riescono maggiormente a soddisfare e quelle che, invece, disattendono più frequentemente. Le prime riguardano: i) la presa in carico e l'attivazione di servizi per pazienti fragili; ii) la collaborazione istituzionale e il confronto con gli stakeholder; iii) l'integrazione tra i servizi sanitari e sociali; iv) l'ascolto e la comunicazione con i diversi attori della filiera. Le aspettative non soddisfatte più di frequente riguardano: i) la gestione della medicina generale (scarsa partecipazione dei MMG a progetti distrettuali, carenza di MMG e PLS, difficoltà a sostituire e stabilizzare incarichi), ii) la garanzia di accesso ai servizi e la riduzione di tempi di attesa; iii) la disponibilità di servizi capillari e sostenibili; iv) la possibilità di avviare nuovi progetti e innovare. Il distretto appare quindi lo snodo di risoluzione dei singoli casi su questioni operative, mentre si dimostra in difficoltà nel rispondere ad attese rispetto a questioni di sistema o strategiche.

Secondo i direttori/direttrici di distretto le loro (e non solo le loro) competenze da rafforzare per gestire le attese degli stakeholder dovrebbero includere: i) competenze gestionali (gestire risorse, organizzare attività, pianificare e valutare servizi, assumere decisioni strategiche e operative costantemente); ii) competenze relazionali, di comunicazione e di negoziazione, al fine di gestire le relazioni con i molteplici stakeholder interni ed esterni; iii) l'orientamento delle persone (leadership) verso obiettivi di rilevanza strategica e di natura aziendale; iv) competenze tecniche sia di conoscenza del territorio e della rete dei servizi sanitari sia legate alle attività amministrative e contabili.

Quali criticità nell'esercizio del ruolo?

Secondo le direzioni di DSS del campione, le criticità legate al loro ruolo sono principalmente le seguenti:

A. Operare fuori gerarchia per via della numerosità di operatori che dipendono da altre strutture organizzative. Il DSS è responsabile di molti processi ma spesso non ha autorità diretta sul personale (il 36% del personale è dipendente) che può dare priorità a quelle attività rilevanti per l'UO da cui proviene. L'assenza di una leva gerarchica, tuttavia, non può essere interpretata solo come una debolezza strutturale, ma anche come spazio interpretativo del ruolo largamente legato alle competenze di relazione e di networking. Fare in modo che le attività distrettuali diventino una priorità al di fuori della leva gerarchica è una espressione specifica del management del DSS. Come richiamato dal Mintzberg, si tratta di passare dalla logica della supervisione diretta a quella dell'aggiustamento reciproco, che genera unitarietà di intenti nella rete informale più che nella responsabilità.
B. Costruire raccordi con il resto dell'azienda, che mantiene ancora un gran numero di strutture organizzative disegnate per setting o per disciplina mentre il DSS è una struttura divisionale che integra servizi. Se il DSS è largamente impegnato nelle attività operative a cavallo tra setting (tipicamente di integrazione tra servizi territoriali -salute mentale, cure primarie, prevenzione- e tra servizi ospedalieri e territoriali), l'organizzazione funzionale dei dipartimenti territoriali e ospedalieri ostacola la gestione di processi orizzontali gestiti dal DSS. Altro raccordo complesso è quello con la direzione strategica: i direttori/direttrici di distretto percepiscono la direzione generale «lontana» dalle questioni operative che li impegnano maggiormente, percezione che non aiuta nella costruzione di sintonie e allineamento sui fini. Sebbene gli allineamenti strategici si costruiscano proprio sui fini, è importante condividere con le direzioni strategiche alcune disfunzionalità sia nella micro-organizzazione del DSS che nei raccordi tra macro-articolazioni organizzative per costruire soluzioni stabili e meno artigianali.
C. Prioritizzare l'allocazione delle risorse in un momento in cui vengono percepite particolarmente scarse rispetto alle necessità dichiarate dai diversi portatori di interesse (in primis, i pazienti). Il processo di allocazione delle risorse si scontra non solo con la loro limitatezza, ma anche con il tema delle attese. Interpretare gli spazi di autonomia che il ruolo lascia non è solo un atto individuale, ma il risultato di un processo che passa per una condivisione delle criticità concrete che la sanità territoriale vive con i portatori di interesse partendo da una visione lucida e non retorica dello stato dell'arte.
D. L'innalzamento delle attese dei cittadini e della «politica» che sovraccarica i processi decisionali soprattutto di tipo allocativo che i direttori/direttrici gestiscono. La grande esposizione relazionale che i direttori/direttrici hanno si gioca spesso attraverso le attività di comunicazione che riempiono la loro agenda. La comunicazione (frammentata) con tutti gli attori interni ed

esterni spesso causa interruzione nei processi, inefficienza e incomprensioni perché è promossa dalle spinte esterne (ad esempio risolvere la carenza per l'erogazione di un servizio). Quindi è spesso una comunicazione di tipo reattivo più che propositivo. In generale, la percezione è che le attese nei confronti dei direttori e delle direttrici di DSS, spesso implicite e a volte contradditorie, rendono il loro ruolo esposto e ad alta vulnerabilità, perché è il punto in cui si scaricano tensioni che non sono occasionali, ma stabili.

11.3.3 L'agenda dei direttori e delle direttrici di DSS

L'analisi sistematica delle agende di 16 direttori/direttrici di distretto delinea in modo empirico intensità, modalità, finalità e variazioni contestuali del loro lavoro quotidiano. Le attività rilevate sono state categorizzate, aggregate e interpretate alla luce dei ruoli manageriali di Mintzberg (1973), come già anticipato.

Il carico di lavoro e le attività principali
Il carico di lavoro medio si attesta intorno a circa 44 ore settimanali, con valori che variano da un minimo di 34 ore a un massimo di oltre 57 ore. La media giornaliera è pari a circa 9 ore, con il 30% dei casi che supera tale valore.

I dati evidenziano una significativa frammentazione e varietà delle attività: il tempo è suddiviso in unità brevi, spesso interrotte da cambi di contesto e di contenuto (oltre che di spostamenti), coerentemente con l'idea *mintzberghiana* di lavoro manageriale. Frammentazione e eterogeneità delle attività svolte sono un elemento della quotidianità dei direttori/direttrici di distretto che appare coerente con la tensione istituzionale e manageriale che stanno vivendo: gli spostamenti in contesti extraurbani sono un tema della quotidianità ma le loro reti istituzionali necessitano di densità di scambi (da quelli per ragioni tecniche – sopralluoghi, collaudi ecc. – a quelli più di natura istituzionale come gli incontri con i sindaci). Nei DSS urbani il rapporto con le strutture ospedaliere e in generale gli erogatori contribuiscono alla pluralità di scambi che essi devono intrattenere. Molti evidenziano il loro coinvolgimento in attività serali, di rappresentanza, durante eventi sia con stakeholder interni che esterni.

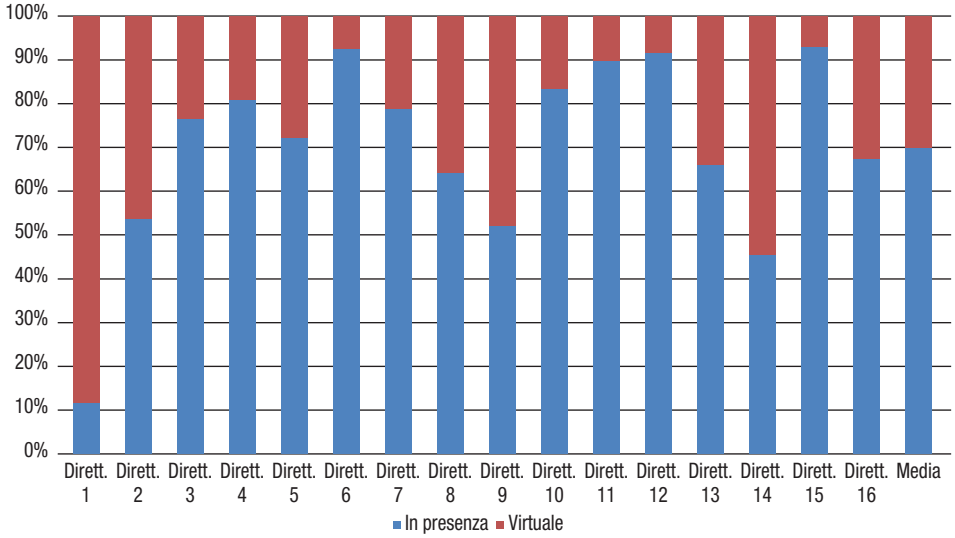
Un elemento chiave dell'analisi è la proporzione tra attività programmate e attività non previste. In media, il 16% del tempo settimanale è dedicato ad attività non programmate, con punte che arrivano fino al 43%, in alcuni casi. Le situazioni superiori alla media sono spesso giustificate dalla necessità di costruire risposte a situazioni di emergenze, criticità operative o richieste improvvise per la gestione di singoli casi (ad esempio la gestione di casi di grande deprivazione sociale) o dalla difficoltà di integrazione tra strutture aziendali o anche extra-aziendali. In generale, si osserva che il direttore/direttrice di distretto interpreta ordinariamente quella funzione di gestione delle crisi ricorrenti, descritta da Mintzberg, che richiede un'elevata capacità adattativa di

gestione dell'imprevisto. Il tema che si pone è la rilevanza di questa attività in alcuni contesti.

La rilevanza delle attività non programmate rischia di inficiare la possibilità che sia il direttore/direttrice di distretto a darsi le proprie priorità. Il tema delle priorità non va inteso come una scelta teorica o una pianificazione ideale, ma come un esercizio quotidiano di selezione, rinuncia e posizionamento. Come osservato da Mintzberg, reattività, ritmo incalzante e assenza di priorità talvolta diventano così importanti, al punto che "è l'agenda a governare il manager, più che il contrario" (Mintzberg, 1973). Come mostrano le agende analizzate, la necessità di darsi un'agenda e non solo farsela fare dall'esterno è consapevolezza percepita che fatica a farsi spazio nella realtà: le urgenze quotidiane, i problemi operativi e le aspettative diffuse tendono ad assorbire gran parte delle energie, lasciando fuori dalla pratica quotidiana proprio le azioni più strategiche.

Rispetto alle forme di relazione, le modalità di interazione registrate sono ibride: il 70% degli scambi avviene in presenza, mentre il restante 30% è gestito a distanza (telefonate, gestione di e-mail e riunioni online). Sebbene non tutte le agende specifichino sistematicamente il formato dell'attività, è emersa una grande variabilità sul tema della fisicità delle interazioni che rappresenta la modalità residuale nei contesti più estesi territorialmente ma anche in quelli più ricchi di relazioni istituzionali come in alcuni contesti metropolitani (Figura 11.6). In ogni caso si osserva una diffusa ibridazione delle modalità: riunio-

Figura 11.6 **Modalità di interazione (valori percentuali)**



Fonte: elaborazione degli autori su agende settimanali dei Direttori / Direttrici di DSS

ni virtuali alternate a momenti in presenza, call rapide intervallate a incontri formali o eventi. Come già illustrato da Mintzberg, i manager prediligono la comunicazione verbale, diretta e reattiva, specialmente per la trattazione di problemi ambigui o sensibili.

I ruoli manageriali agiti e le finalità

L'analisi testuale e codificata delle attività ha permesso di attribuire, per ogni segmento orario, uno o più ruoli manageriali prevalenti, come descritti da Mintzberg. L'analisi è stata fatta considerando due piani: il contenuto specifico delle attività e i fini dell'azione svolta. Questo è stato ritenuto necessario sia per comparare le diverse interpretazione di ruolo agita dai direttori/direttrici in contesti diversi sia per affinare l'interpretazione di ciascuna attività proprio per la sovrapposizione dei ruoli e l'ambivalenza di alcune attività.

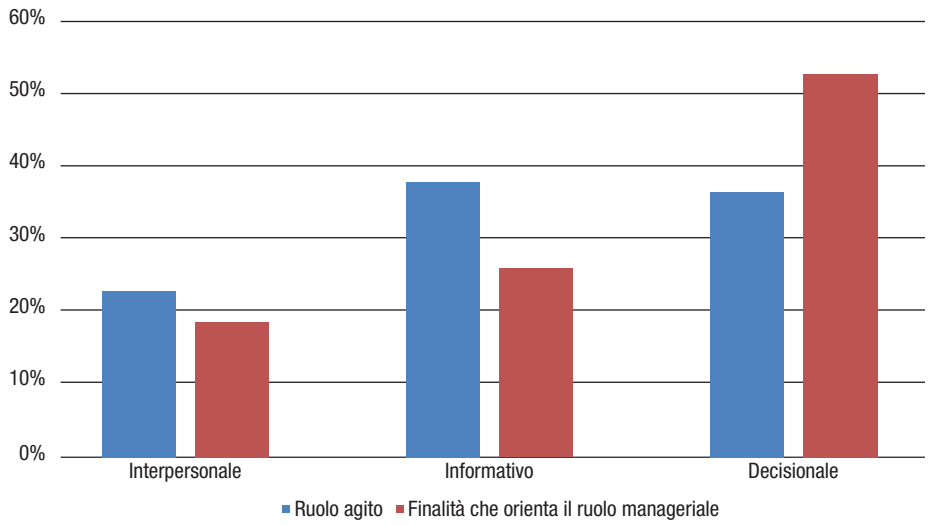
Complessivamente, il 38% del tempo è riconducibile a ruoli informativi, il 36% a ruoli decisionali e il 23% a ruoli interpersonali (valori medi). In alcuni casi (3 su 16), i direttori/direttrici ricoprono ulteriori incarichi aziendali o regionali che influiscono sulla loro agenda in misura marginale (2,2% del loro tempo) o in maniera significativa (38% del loro tempo). In dettaglio, i contenuti specifici dei ruoli più frequentemente agiti sono:

- osservatore attivo (26%): raccogliere informazioni, monitorare i processi, ascoltare gli attori del territorio. All'interno di questo ruolo sono inserite le numerose attività nell'ambito del PNRR. Esempi di attività riportate dai Direttori e Direttrici che rientrano in questo ruolo sono «*la raccolta di documentazione in preparazione della visita di monitoraggio ministeriale sul PUA in CdC finanziata con PNRR*» (Dirett. 1)*; «la raccolta dei fabbisogni dei Distretti per la definizione del personale infermieristico da assegnare alle COT*» (Dirett. 5).
- Allocatore di risorse (25%): gestire l'operatività del distretto, le risorse economiche, professionali e infrastrutturali. Esempi di attività citate sono «*coordinamento e gestione delle attività distrettuali e gestione delle agende aziendali*» (Dirett. 4)*; «definizione delle modalità di distribuzione dei defibrillatori*» (Dirett. 3).
- Rappresentante simbolico (13%): esercitare un ruolo di presidio istituzionale e visibilità pubblica. Esempi di attività citate sono: «*partecipazione all'inaugurazione della nuova sede del day surgery*» (Dirett. 9) o «*la firma delle determine*» (Dirett. 12).
- Portavoce (9%): comunicare con i vertici aziendali (Direzione strategica) o con gli stakeholder esterni. Esempi di attività sono «*la diffusione di un progetto attraverso i mass media*» (Dirett. 15); o «*la condivisione con soggetti esterni dei percorsi PUA e il monitoraggio delle attività*» (Dirett. 7).

Se si analizza anche la finalità che orienta il comportamento manageriale, ovvero l'obiettivo ultimo che guida l'azione, si osserva un importante riequilibrio del peso relativo dei ruoli: in particolare, i ruoli decisionali assumono un rilievo ancora maggiore, raggiungendo il 53% del totale, così come i ruoli informativi (26%) (Figura 11.7). Tale dato è confermato se si analizzano i singoli ruoli (Figura 11.8). Il ruolo di "allocatore di risorse" diventa, infatti, quello predominante (34%).

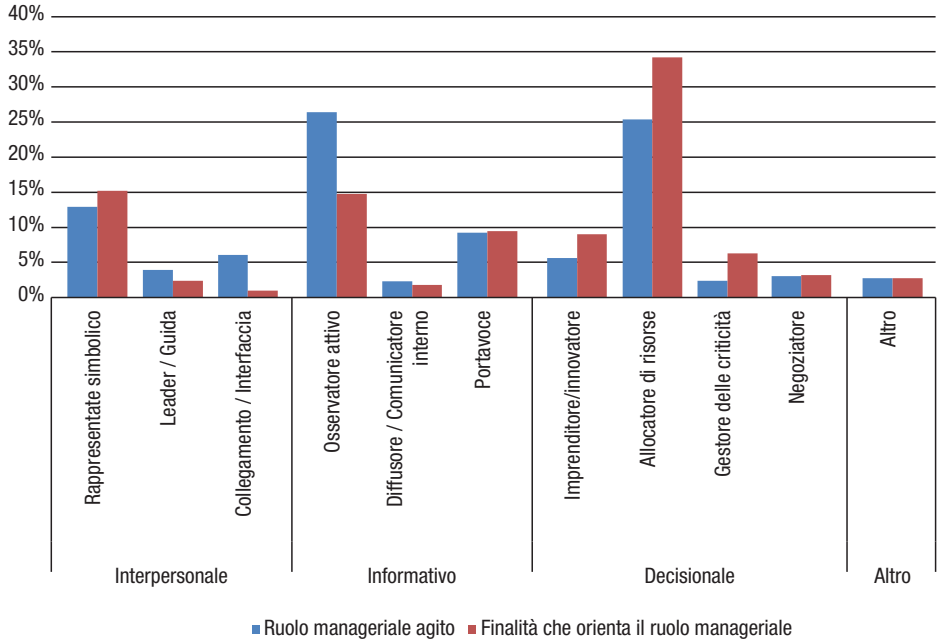
Questo scarto tra ruolo agito e finalità sottostante suggerisce che molte delle attività che in apparenza rientrano tra i ruoli informativi o interpersonali (come raccogliere informazioni, comunicare, partecipare a incontri o gestire relazioni) sono in realtà strumentali a consentire o sostenere una decisione. In altri termini, il direttore/direttrice utilizza l'interazione e la comunicazione come leva per costruire consapevolezza, legittimazione e coordinamento rispetto a scelte da assumere. Alcuni esempi concreti, emersi dalle agende, chiariscono questa dinamica: in un caso si annota un'attività di *"analisi dell'andamento della spesa su fondi disponibili"* (ruolo agito: osservatore), con la finalità esplicita di *"programmazione dei fondi distrettuali e analisi mensile della spesa"* (finalità del ruolo: allocatore di risorse). Analogamente, in un altro caso si descrive un'attività di *"analisi delle segnalazioni URP"* (ruolo agito: osservatore) che sfocia nella necessità di *"richiamare un verbale e gestire una criticità"* (finalità del ruolo: gestore delle crisi).

Figura 11.7 **Ruolo manageriale agito e finalità che orienta il ruolo manageriale (valore %)**



Fonte: elaborazione degli autori su agende settimanali dei Direttori / Direttrici di DSS

Figura 11.8 **Ruoli agiti e finalità che orienta il ruolo manageriale (dettaglio)**



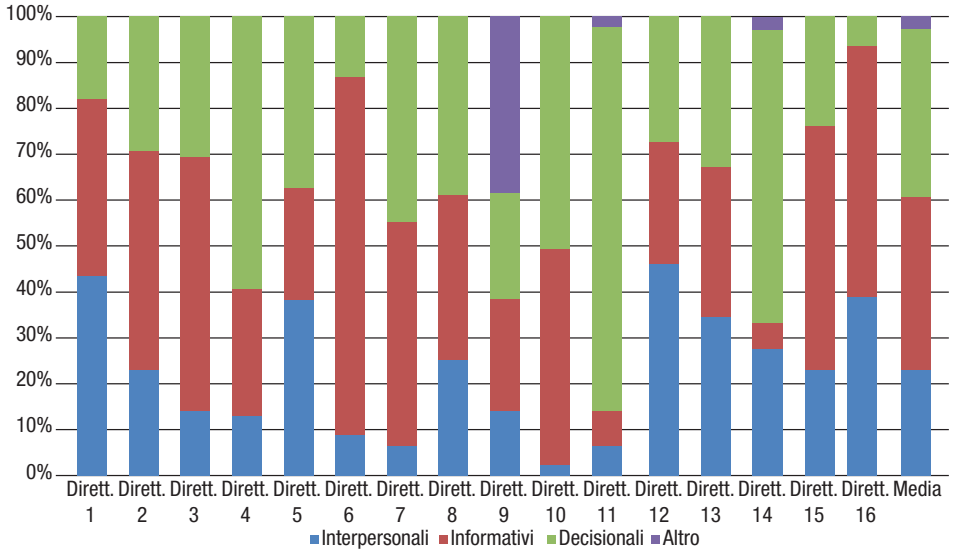
Fonte: elaborazione degli autori su agende settimanali dei Direttori / Direttrici di DSS

Ciò che emerge è perfettamente coerente con quanto descritto da Mintzberg, secondo cui i ruoli non sono compartimenti stagni ma funzioni che si sovrappongono, si abilitano a vicenda e spesso si integrano in sequenze strategiche di azione. Complessivamente, questi elementi restituiscono l'immagine di una funzione di "regia territoriale", già emersa anche nell'analisi delle aspettative degli stakeholder interni ed esterni (sezione 11.3.2).

L'analisi delle agende mette in luce differenze rilevanti tra direttori/direttrici sia per intensità del lavoro settimanale sia per il peso relativo di alcuni ruoli (es. ruolo di portavoce o imprenditore/innovatore). Guardando ai ruoli agiti, alcune agende evidenziano una forte focalizzazione su attività di allocazione delle risorse, coordinamento interno e gestione operativa (ruoli più decisionali – Dirett. 4, 11 e 14), mentre altre sono maggiormente caratterizzate da incontri con attori istituzionali o attività di rappresentanza esterna – ruoli interpersonali (Dirett. 1, 5, 12) o da attività più informative (Dirett. 2, 3, 6) (Figura 11.9).

Tali differenze non si sfumano se si fa un affondo regionale: anche all'interno dell'Emilia-Romagna, di cui sono disponibili più rilevazioni, si evidenzia tale eterogeneità: alcuni profili si caratterizzano per un forte orientamento alla rappresentanza simbolica (Dirett. 16), altri per un ruolo di collegamento

Figura 11.9 **Variabilità nelle agende dei Direttori / Direttrici (valore % – ruoli agiti)**



Fonte: elaborazione degli autori su agende settimanali dei Direttori / Direttrici di DSS

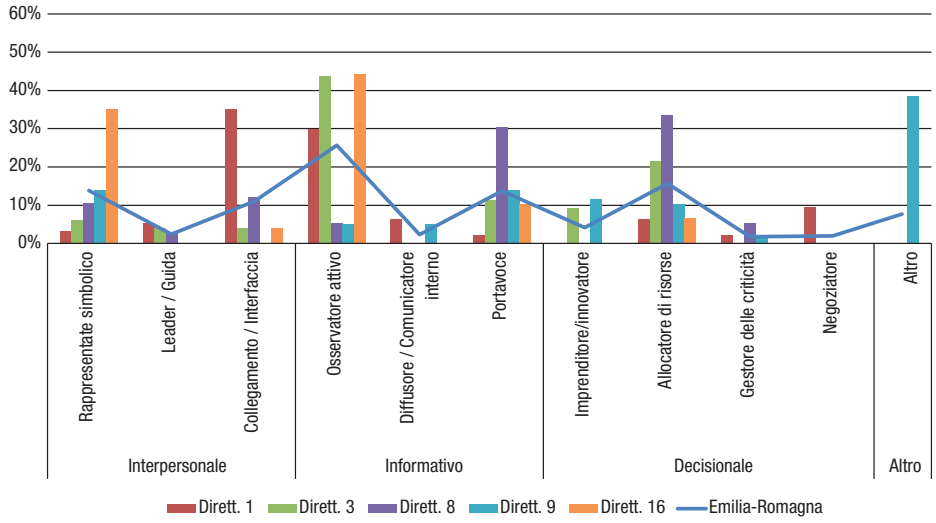
/ interfaccia con i diversi attori (Dirett. 1), altri per l'osservazione diretta e raccolta di informazioni (Dirett. 3 e 16) e, infine, altri per l'esercizio del ruolo di portavoce e allocatore di risorse (Dirett. 8) (Figura 11.10). Inoltre, in un caso una buona parte dell'attività settimanale è connessa allo svolgimento di un altro incarico, nel grafico rappresentato sotto la voce "Altro". Queste differenze all'interno della stessa regione suggeriscono come l'interpretazione di ruolo sia influenzata certamente dalle caratteristiche individuali ma anche il sistema delle attese locali ha un ruolo sostanziale.

Stakeholder coinvolti interni ed esterni

Nel 93% delle attività analizzate è presente una interazione con altri attori: nel 46% dei casi si tratta di stakeholder interni, nel 26% di attori esterni (comuni, terzo settore, cittadini), e nel 28% di interlocuzioni con entrambi i target. Questa distribuzione conferma il ruolo della direzione distrettuale quale nodo relazionale che opera come doppia interfaccia, "verso l'interno" per garantire coerenza organizzativa interna e "verso l'esterno" per garantire tenuta istituzionale esterna.

Le agende confermano e approfondiscono quanto emerso dall'analisi delle loro percezioni: con gli stakeholder interni prevalgono i ruoli decisionali ("Allocatore di risorse" – 25%) e informativi ("Osservatore attivo" – 23%); con gli stakeholder esterni, quelli informativi ("Osservatore attivo" – 49%, "Portavoce" – 11%) e interpersonali ("Rappresentate simbolico"- 17%, "Collegamento

Figura 11.10 **Variabilità intra-regionale: Emilia-Romagna (ruolo agito)**



Fonte: elaborazione degli autori su agende settimanali dei Direttori / Direttrici di DSS

Tabella 11.5 **Ruolo agito nel rapporto con i vari stakeholder**

Ruolo agito	Stakeholder		
	Esterni	Interni	Misti
Interpersonale			
Rappresentate simbolico	17%	11%	15%
Leader / Guida	1%	9%	0%
Collegamento / Interfaccia	11%	4%	10%
Informativo			
Osservatore attivo	49%	23%	24%
Diffusore / Comunicatore interno	0%	5%	1%
Portavoce	11%	6%	16%
Decisionale			
Imprenditore/innovatore	2%	8%	5%
Allocatore di risorse	5%	25%	22%
Gestore delle criticità	2%	5%	0%
Negoziatore	2%	3%	5%
Altro	0%	0%	1%

Fonte: elaborazione degli autori su agende settimanali dei Direttori / Direttrici di DSS

/ Interfaccia" – 11%); mentre con interlocutori misti si riscontra una sintesi tra ruoli informativi ("Osservatore attivo" – 24%, "Portavoce" – 16%), decisionali ("Allocatore di risorse" – 22%) e interpersonali ("Rappresentate simbolico" – 15%, "Collegamento / Interfaccia" – 10%) (Tabella 11.5).

11.4 Discussione e conclusioni

Il capitolo ha approfondito il ruolo dei direttori e delle direttrici di distretto e la macro-articolazione dei DSS, oggi al centro di un processo di trasformazione profonda indotto dall'attuazione del DM 77/2022 e dalla Missione 6 del PNRR. Si tratta di iniziative di portata nazionale, adottate da tutte le Regioni e implementate da tutte le ASL. Raramente, in passato, si è assistito a una priorità così trasversale, capace di orientare in modo duraturo le scelte organizzative e gestionali su tutto il territorio. È dunque una spinta al cambiamento che per la prima volta pone la rete dei servizi territoriali al centro del dibattito e dell'azione manageriale, sostenuta dalle risorse straordinarie del PNRR.

L'attività di ricerca ha beneficiato di questa convergenza di intenti, concentrandosi su una famiglia professionale – quella dei direttori e delle direttrici di distretto – caratterizzata da un'elevata eterogeneità di ruoli e di *background*, che rende complessa l'analisi sistematica. Il tratto comune risiede nella collocazione di questi professionisti nel *middle management* aziendale e nella loro funzione di guida di strutture organizzative di tipo divisionale (dedicate all'integrazione delle risorse per specifici territori) che stanno vivendo una importante trasformazione della loro rete dei servizi e delle prassi e condizioni operative di funzionamento. L'attualità del DSS e del ruolo di direzione distrettuale in questa fase storica è ribadita dallo sforzo formativo messo in campo dalle Regioni: corsi e percorsi di aggiornamento dedicati a questo target professionale sono stati finanziati dalla misura M6C2.2c e stanno popolando le loro agende, così come la ricerca ha dimostrato.

La rinnovata centralità del DSS si traduce, quindi, anche in un nuovo interesse per la figura del direttore/direttrice di distretto. L'esperienza pandemica aveva già rivelato il ruolo cruciale del DSS nell'intermediazione tra servizi ospedalieri e territoriali e promosso una certa consapevolezza in questa direzione. Inoltre, all'interno del Network DiSS si è osservata una crescente mobilità di carriera: alcuni hanno assunto ulteriori responsabilità in ambito territoriale (screening, cure intermedie), altri sono passati a ruoli di direzione sanitaria o generale. Stiamo assistendo, dunque, a una maggiore attrattività e agilità di carriera, favorita proprio da quella eterogeneità dei percorsi formativi e professionali che caratterizzano l'accesso al ruolo. Quindi, questo rilancio sta facendo sbiadire l'immagine di chi approdava al ruolo di direzione distrettuale per insuccessi in ambito ospedaliero. Quelli analizzati nell'indagine si dimostrano impegnati e motivati nelle sfide poste dal PNRR e dal DM77/22 e con un buon profilo formativo (oltre il 45% possiede un master universitario di II livello e il 9% un dottorato di ricerca). Non si può negare che il campione osservato non sia rappresentativo dell'universo di riferimento e che quindi esistano ancora interpretazioni datate di questo ruolo. Quello che preme sottolineare è che attraverso questo ruolo si sta giocando non solo una partita professionale,

ma il campionato della trasformazione dei servizi territoriali. Quindi, supportare i profili già ingaggiati e motivare quelli che questo campionato faticano a giocarlo, è una priorità generale che non si esaurisce con l'attivazione di percorsi formativi privi di una lettura contingente e profonda che il ruolo assume nei diversi contesti.

Questa diversa identità di ruolo è funzionale all'interpretazione della missione istituzionale che l'azienda interpreta nei diversi territori ed è condizionata almeno da due elementi. Il primo riguarda la cultura manageriale vissuta in azienda: un approccio eccessivamente burocratico rischia di schiacciare il ruolo su una dimensione formale, allontanandolo dai bisogni concreti della popolazione e dagli operatori, spesso non dipendenti. La seconda concerne l'interpretazione del ruolo che ciascuno è capace di produrre: le scelte organizzative, le caratteristiche del territorio e il *background* di ciascun direttore/direttrice rendono ogni DSS un unicum, sia per le forme di autonoma manageriale possibili che per la difficoltà di comparare esperienze e modelli. Laddove l'autonomia è temuta, si osserva una richiesta di maggior rigore formale nel delimitare attraverso norme e regolamenti il perimetro delle attività di competenza del direttore/direttrice. I due fenomeni sono in grande connessione, rischiando di innescare un vero corto circuito.

Dal punto di vista organizzativo, la micro-organizzazione del DSS risulta spesso inadeguata rispetto alla funzione di integrazione da assolvere. Dove esistono strutture organizzative sub-distrettuali, esse sono solitamente definite per setting assistenziale (anche i CdR sono progettati col medesimo criterio). Quindi, abbiamo un sistema di responsabilità disegnato sull'offerta e non sulla domanda. Ne consegue che la gestione dei pazienti complessi, che richiede, ad esempio, la combinazione di servizi domiciliari e ambulatoriali, ricade su sistemi operativi territoriali ancora deboli – dai sistemi informativi al monitoraggio delle attività. In molti casi è lo stesso direttore di DSS a farsi carico dell'integrazione tra setting appartenenti a responsabilità organizzative diverse. Le COT rappresentano un importante passo avanti in questa direzione, ma occorre riflettere anche su nuove responsabilità organizzative fondate sulla domanda di salute, non solo sull'offerta dei servizi. L'omogeneità del modello di organizzazione (micro e macro) del DSS è storicamente stato visto come un ingrediente fondamentale della ricetta dell'equità. La realtà è già largamente diversa in ciascun contesto e ricostruire un'organizzazione e un sistema di responsabilità più legato ai processi, alla domanda e ai risultati attesi è una leva di management da attivare per rendere il DSS più contemporaneo.

L'ibridazione del sistema (ovvero la compresenza di circuiti di spesa sanitaria pubblica e privata in capo al singolo cittadino) impone di ripensare i paradigmi di committenza e produzione territoriale. Quello che ci raccontano i direttori/direttrici coinvolti nella ricerca è che l'incoerenza tra domanda e capacità di

offerta si sta scaricando a livello locale proprio sul DSS. Sebbene la riflessione su queste funzioni (committenza vs produzione territoriale) risalga agli anni '90, oggi il tema torna centrale: i direttori di distretto sono chiamati a operare scelte allocative su risorse sempre più scarse, a fronte di una domanda crescente e complessa. Devono quindi bilanciare priorità, esclusioni e modulazioni dell'intensità assistenziale, ponendosi la domanda chiave: come rispondere ai bisogni di salute con le risorse effettivamente disponibili? Questi interrogativi non possono ignorare l'opportunità di integrare risorse pubbliche e private, dal welfare aziendale alle forme di spesa sanitaria intermediata, per progettare interventi specifici sul singolo. Come è possibile affrontare questa sfida del presente se nella committenza non si osserva chi rimane fuori dai servizi (non si fa riferimento alle liste di attesa, ma ai target fragili) e nella produzione anche ciò che è finanziato alla spesa sanitaria privata?

Il management del distretto si esercita spesso fuori dagli schemi gerarchici e beneficia di competenze di networking sia nella gestione degli stakeholder interni che di quelli esterni. Ogni direttore/direttrice gestisce relazioni con circa nove interlocutori interni e dodici esterni. Se nella gestione delle relazioni esterne appaiono cruciali competenze nelle relazioni istituzionali (che potremmo definire politiche) in quelle interne prevalgono quelle nella negoziazione di risorse e competenze che afferiscono gerarchicamente ad altre partizioni dell'azienda ma che operano anche all'interno del DSS. Si tratta di un riorientamento alla missione territoriale di operatori che spesso insistono sull'ospedale. Questa è più un'operazione di *sense making* che passa per una rivisitazione con le diverse comunità professionali del loro modello di cura spostandolo più in prossimità. Lo sforzo allocativo dichiarato soprattutto con i portatori di interesse interni all'azienda è il risultato di questo sforzo.

La spinta al cambiamento indotta dal PNRR e dal DM77/22 sono il banco di prova della trasformazione di ruolo potenzialmente in corso, stressando ulteriormente le caratteristiche del lavoro manageriale individuate da Mintzberg:

A. Il ritmo delle attività quotidiane è notevolmente aumentato con l'attuazione del DM 77/22 e del PNRR. La pressione implementativa è evidente e varia a seconda del grado di supporto offerto dalle ASL: alcune hanno avviato veri processi di *change management*, altre lasciano i direttori più isolati nel fronteggiare decisioni operative complesse.
B. I direttori/direttrici di distretto mostrano una naturale propensione all'azione. Molto del loro impegno operativo è assorbito dalla gestione di singoli casi clinici complessi o dall'avvio di nuovi servizi (Ospedali di Comunità, telemedicina, ecc.). Tuttavia, questa operatività può risultare reattiva, con priorità spesso definite dall'esterno più che da strategie proprie.
C. Il lavoro è ampio, vario e frammentato: mediamente 44 ore settimanali più ulteriori impegni serali legati a comunicazioni o attività istituzionali. La

percezione di frammentarietà è aumentata per effetto delle numerose iniziative formative e di progetto collegate al PNRR.

D. Infine, emerge la "paura dell'autonomia manageriale". Molti avvertono il disagio legato alla mancanza di una cornice normativa chiara che definisca il loro ruolo e le loro responsabilità. Questa incertezza alimenta atteggiamenti difensivi e burocratici, ostacolando l'esercizio pieno dell'autonomia gestionale. Inoltre, la rendicontazione del PNRR, centrata su adempimenti formali, non aiuta a sviluppare una cultura della responsabilità manageriale orientata ai risultati. Creare spazi di confronto condiviso tra direzioni generali, strutture territoriali e ospedaliere può rappresentare una palestra di autonomia, utile a costruire nuove metriche per valutare i cambiamenti effettivamente generati.

Il DSS e i suoi direttori/direttrici si trovano oggi al crocevia tra innovazione organizzativa e pressione operativa. La loro azione concreta, la capacità di mediazione e la gestione della complessità rappresentano una sfida importante per l'attuazione della "riforma" territoriale disegnata dal DM 77/22 e sostenuta dal PNRR.

11.5 Bibliografia

Bandiera, Oriana, Andrea Prat, Stephen Hansen, e Raffaella Sadun. 2020. «CEO behavior and firm performance». *Journal of Political Economy* 128 (4): 1325–69.

Birken, S. A., Lee, S. Y. D., & Weiner, B. J. (2012). Uncovering middle managers' role in healthcare innovation implementation. Implementation Science, 7(1), 28.

Birken, S. A., Lee, S. Y. D., Weiner, B. J., Chin, M. H., Chiu, M., & Schaefer, C. T. (2015). From strategy to action: how top managers' support increases middle managers' commitment to innovation implementation in health care organizations. Health care management review, 40(2), 159-168.

Birken, S., Clary, A., Tabriz, A. A., Turner, K., Meza, R., Zizzi, A., ... & Charns, M. (2018). Middle managers' role in implementing evidence-based practices in healthcare: a systematic review. Implementation Science, 13(1), 149.

Boutcher, F., Berta, W., Urquhart, R., & Gagliardi, A. R. (2022). The roles, activities and impacts of middle managers who function as knowledge brokers to improve care delivery and outcomes in healthcare organizations: a critical interpretive synthesis. BMC health services research, 22(1), 11.

Cinelli, G., Dalponte, F., Ferrara, L., Tozzi, V. D., & Zazzera, A. (2023). L'implementazione del DM77 nelle regioni italiane e il ruolo delle aziende sanitarie. In Rapporto OASI 2023 (pp. 407-431). Egea.

Cinelli, G., Dalponte, F., Ferrara, L., Tozzi, V.D. , & Zazzera, A. (2024). Gestire il cambiamento al tempo del PNRR e del DM77: il caso delle COT. In Rapporto OASI 2024 Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano (pp. 421-446). Egea.

Dalponte, F., Ferrara, L., & Tozzi, V. D. (2022). La trasformazione del Distretto Socio Sanitario. In Rapporto OASI 2022 (pp. 521-547). Egea.

Fayol, Henri. 1916. *General and industrial management*. Pitman.

Embertson, M. K. (2006). The importance of middle managers in healthcare organizations. Journal of Healthcare Management, 51(4), 223.

Johnson, Bart, e Dawn Dobni. 2016. «Is managerial work in the public and private sectors really "different"? A comparative study of managerial work activities». *International Journal of Public Administration* 39 (6): 459–69.

Lega, Federico, Andrea Rotolo, e Marco Sartirana. 2022. «Dealing with pluralism: the managerial work of CEOs in Italian public healthcare organizations». *BMC Health Services Research* 22 (1): 1222. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08567-1.

Mintzberg, Henry. 1973. *The Nature of Managerial Work*. Harper & Row.

Mintzberg, Henry. 1990. «The Managers Job: Folklore and Fact: Harvard Business Review». *Mar Apr*, 163–70.

Tengblad, Stefan. 2006. «Is There a 'New Managerial Work'? A Comparison with Henry Mintzberg's Classic Study 30 Years Later». *Journal of Management Studies* 43 (7): 1437–61. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00651.x.

Tengblad, Stefan, e Ola Edvin Vie. 2012. «Management in practice: Overview of classic studies on managerial work». In *The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management*, a cura di Stefan Tengblad. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199639724.003.0002.